

De complete gids voor betere slaap na 40

Alles wat je moet weten over slaaphygiëne, gerichte supplementen en ritme-opbouw — in één overzichtelijke PDF.

- ▢ Waarom magnesiumglycinaat praktischer is dan oxide voor slaapkwaliteit
- ▢ Een 7-dagen protocol dat je direct kunt inzetten — met 'niet doen'-lijsten per fase
- ▢ Doseringen in perspectief: magnesium, ashwagandha, melatonine en L-theanine
- ▢ Veelgemaakte fouten die je slaap saboteren zonder dat je het doorhebt

Slaap is het fundament waar stressbeheer en herstel op rusten. Verbeter eerst je ritme en omgeving — daarna zijn supplementen pas zinvol als gerichte aanvulling.

— PerfectSupplement — redactioneel uitgangspunt

Inhoudsopgave

-
- 01 Waarom je slaap verandert na 40

 - 02 De 5 grootste slaapfouten (+ een veel voorkomende zesde)

 - 03 Het 7-dagen slaapritme-protocol

 - 04 Supplementen die werken (en context)

 - 05 Doseringen en veiligheid (globaal kader)

 - 06 Week-voor-week actieplan

 - 07 Veelgestelde vragen
-

01 Waarom je slaap verandert na 40

Na je 40e veranderen er drie dingen die direct impact hebben op hoe je slaapt. Dit is geen kwestie van discipline — het is biologie. Als je begrijpt wat er verschuift, kun je gericht ingrijpen.

Je melatonine-productie daalt geleidelijk

Melatonine helpt je circadiaanse ritme te sturen (donker signaleert: tijd om te rusten). De **melatonineproductie daalt** na je 40e¹; ook speelt op langere termijn geleidelijk verminderde secretie een rol². In mensen ouder dan 90 jaar ligt melatonine gemiddeld op **minder dan 20%** van het niveau bij jonge volwassenen — individueel sterk verschillend³. Praktisch merk je dat als 'intrappen' lastiger wordt en je lichter slaapt.

Je diepe slaap kan relatief korter worden

Slaap bestaat uit cycli met lichte slaap, diepe slaap en REM. Diepe slaap is een belangrijke schakel voor herstel en consolidatie. Meta-analyses laten zien dat kwantitatieve slaapparameters — waaronder diepe slaap — met de leeftijd verschuiven; **diepe slaap neemt relatief af na 40**⁴. Het totaal kan nog hetzelfde voelen qua uren, terwijl de verdeling minder gunstig wordt — je wordt sneller wakker en minder uitgerust.

Cortisol kan je avond onnodig 'warm' houden

Cortisol hoort later op de dag te zakken zodat je systeem kan schakelen naar rust. Bij langdurige stress blijft het avondniveau soms te hoog — het **saboteert je avond** en kan samenhangen met verstoring van herstelsignalen en hormoonbalans⁵. Het gevolg: je bent moe, maar je lichaam staat nog te veel op scherp.

Het klassieke patroon

In slaap vallen gaat nog, maar rond 03:00 word je wakker met bonzend hart en een hoofd dat niet stilstaat. Dat past bij een te vroege of te harde 'opstart' van stress-as activiteit — maak overdag ventilatie en ritme prioriteit, niet alleen 's nachts harder proberen te slapen.

Slaap en testosteron zitten aan elkaar gekoppeld

In endocrinologische literatuur wordt benadrukt dat een groot deel van de dagelijkse testosteronrelease pulseert met slaap en met name met **diepe slaap**. Als vuistregel wordt wel genoemd dat ongeveer **70–80%** van de dagelijkse testosteronproductie tijdens slaap plaatsvindt of daarmee samenhangt — kwetsbaar dus als diepe slaap structureel terugloopt⁶. Dit is géén diagnose: het is een reden om slaap serieus te nemen.

Bronnen

- ¹ Wurtman RJ. Age-Related Decreases in Melatonin Secretion—Clinical Consequences. *J Clin Endocrinol Metab.* 2000;85(6):2135–2136. PMID: 10852443
- ² Hardeland R. Melatonin in Aging and Disease—Multiple Consequences of Reduced Secretion, Options and Limits of Treatment. *Aging Dis.* 2012;3(2):194–225. PMC3377831
- ³ Claustrat B, Leston J. Melatonin: Physiological effects in humans. *Neurochirurgie.* 2015;61(2–3):77–84.
- ⁴ Ohayon MM et al. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals. *Sleep.* 2004;27(7):1255–1273. PMID: 15586779
- ⁵ Leproult R, Van Cauter E. Effect of 1 week of sleep restriction on testosterone levels in young healthy men. *JAMA.* 2011;305(21):2173–2174. PMID: 21632481
- ⁶ Wittert G. The relationship between sleep disorders and testosterone in men. *Asian J Androl.* 2014;16(2):262–265. PMC3955336

02 De 5 grootste slaapfouten (+ een veel voorkomende zesde)

De meeste mannen 40+ maken dezelfde fouten — niet uit onwetendheid, maar omdat dit op je 30e vaak nog 'werkte'. Na 40 tikt elke verstoring harder door.

Fout 1: Cafeïne laat op de dag

Cafeïne heeft een halfwaardetijd van ongeveer **5–6 uur**⁷. Een latte om 15:00 kan 's avonds nog merkbaar aanwezig zijn. **Dit geldt ook voor sterke groene thee en veel energiedranken** — niet alleen espresso.

Fout 2: Scherm tot aan bed

Helder licht en vooral **blauwrijk schermlicht onderdrukt 's avonds melatonine**⁸. Zet je telefoon minimaal 45–60 minuten voor slapen uit het bereik — niet alleen op zijn kant.

Fout 3: Willekeurige bedtijden

Je klok houdt niet van sociale jetlag. Streef naar opstaan binnen hetzelfde venster (± 30 min), ook in het weekend.

Fout 4: Te laat zwaar trainen

Intensieve training laat je systeem nog lang nagloeien. Plan zware blokken liever eerder op de avond; een rustige wandeling kan juist helpen om af te bouwen.

Fout 5: Een slaapkamer die te warm is — en alleen maar aan het klimaat denken

Voor veel mensen is een slaapkamer van **ongeveer 16–18 °C** gunstig voor inslapen⁹. Thermoregulatie gaat ook over timing: **90 minuten voor bed een warme douche** gevolgd door afkoeling kan inslapen helpen door een duidelijke daling van kerntemperatuur daarna.

Fout 6: Te lang in bed liggen terwijl je niet slaapt

Als je regelmatig wakker ligt, daalt je **slaapefficiëntie** — het deel van de tijd in bed dat je echt slaapt. Vaak is **7 uur in bed met 6,5 uur slapen** gunstiger dan **9 uur in bed met dezelfde 6,5 uur slapen**, omdat je brein bed niet associeert met frustratie en piekeren. Sta op, zoek rust zonder scherm, en ga pas terug als je weer slaapdruk voelt.

Bronnen

⁷ Drake C et al. Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. J Clin Sleep Med. 2013;9(11):1195–1200. PMID: 23805807

⁸ Chang AM et al. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep. Proc Natl Acad Sci USA. 2015;112(4):1232–1237. PMID: 25535358

- ⁹ Okamoto-Mizuno K, Mizuno K. Effects of thermal environment on sleep and circadian rhythm. J Physiol Anthropol. 2012;31(1):14. PMC3427038

03 Het 7-dagen slaapritme-protocol

Dit protocol stapelt gedrag — je hoeft niet alles perfect te doen. Focus op consistentie.

Dag 1–2: Basis

- Vaste opstaantijd (ook weekend)
- Cafeïne niet na lunch
- Slaapkamer koeler en donkerder maken

Niet doen (fase 1)

Geen 'compensatie-siesta' van 90 minuten midden op de dag; geen laat avondmaal met veel alcohol 'om te ontspannen'.

Dag 3–4: Avondafsluiting

- Schermen weg vanaf 45–60 min voor slapen
- Eenvoudig ritueel: lezen, stretch, ademhaling
- Geen alcohol als slaapmiddel — niet 'even een glas' om sneller weg te zijn

Niet doen (fase 2)

Geen zware discussies of werk-mail vlak voor bed; geen scherm in bed 'nog één video'.

Dag 5–6: Daglicht en lichte beweging

- **Daglicht binnen 30 minuten na opstaan** om je circadiaanse klok te verankeren¹⁰
- Rustige wandeling na diner om spanning af te bouwen

Niet doen (fase 3)

Geen late HIIT of maximale kracht sessie na 20:00 als je merkt dat je dan hoger op tilt staat.

Dag 7: Check

Noteer in één minuut: inslaaptijd, nachtelijke wakker periodes, ochtendfrisheid (1–10). Dat is je baseline voor de volgende weken.

Niet doen (fase 4)

Geen dramatische 'alles-of-niets' correctie op dag 7 – kies maximaal één extra stap voor week 2.

Tip: Overweeg vanaf dag 3 magnesiumglycinaat als onderdeel van je avondroutine (zie hoofdstuk 5 voor dosering).

Bronnen

¹⁰ Blume C et al. Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. *Somnologie*. 2019;23(3):147–156. PMC6751071

04 Supplementen die werken (en context)

Supplementen zijn geen vervanging voor ritme, licht, temperatuur en stresshuishouding. Als de basis klopt, kunnen ze wél gericht ondersteunen.

Magnesium — vaak de eerste logische stap

Magnesium speelt mee in talloze processen, waaronder neurotransmitters en spierspanning; studies naar bisglycinaat en bredere magnesium-suppletie rapporteren verbeteringen in **slaapkwaliteit** bij sommige populaties¹¹¹². Niet elke vorm is gelijkwaardig voor slaapdoelen.

Vorm	Opname / gebruik	Slaap-context
Glycinaat / bisglycinaat	Meestal goed verdragen	Zeer gangbaar voor avondroutine
Citraat	Andere toilet-gevoeligheid	Soms gekozen om andere redenen
Oxide	Lagere biologische beschikbaarheid	Minder geschikt als hoofdoptie
L-theanine (aminozuur uit thee)	Geen sedatie bij veel gebruikers	Vaak 100–200 mg voor slapen; ontspanning zonder 'chemisch suf'
Ashwagandha (KSM-66)	Langduriger gebruik	Interessant bij stress-gestuurde slaap

Het aminozuur **glycine** — onderdeel van glycinaatverbindingen — heeft kalmerende eigenschappen die in onderzoek met slaapkwaliteit in verband worden gebracht¹³.

Ashwagandha — vooral bij stress-gestuurde slaapproblemen

Extracten zoals KSM-66 zijn onderzocht op **cortisol** en stressklachten en tonen in RCT's verbetering ten opzichte van placebo — relevant als je slaap vooral door spanning lijdt¹⁴¹⁵. Het is onderdeel van een breder plan — niet als enige hefboom.

Melatonine — laagdrempelig, maar niet structureel voor iedereen

Microdosering kan soms helpen bij ritmeverstoring; reviews benadrukken dat **langdurig dagelijks gebruik zonder medische evaluatie zelden nodig is**¹⁶.

L-theanine — rust zonder zware sedatie

L-theanine komt van thee en wordt veel onderzocht op kalmerende effecten zonder dezelfde 'knock-out' als sommige slaapmiddelen. Gangbare avonddosering is vaak **200 mg**, 30–60 minuten voor slapen — start conservatief.

Stapelen vs. niet stapelen

Begin met één supplement. Voeg pas na minimaal **2 weken** een tweede toe als je basis al aanvoelt alsof die klopt. Zo weet je wat bijdraagt — en wat alleen kosten en complexiteit toevoegt.

Bronnen

- ¹¹ Schuster J et al. Magnesium Bisglycinate Supplementation in Healthy Adults Reporting Poor Sleep: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. *Nat Sci Sleep*. 2025;17. PMC12412596
- ¹² Rawji A et al. Examining the Effects of Supplemental Magnesium on Self-Reported Anxiety and Sleep Quality: A Systematic Review. *Cureus*. 2024;16(4):e59317. PMC11136869
- ¹³ Bannai M, Kawai N. New therapeutic strategy for amino acid medicine: glycine improves the quality of sleep. *J Pharmacol Sci*. 2012;118(2):145–148. PMID: 22293292
- ¹⁴ Lopresti AL et al. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Medicine*. 2019;98(37):e17186. PMC6979308
- ¹⁵ Chandrasekhar K et al. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. *Indian J Psychol Med*. 2012;34(3):255–262. PMID: 23439798
- ¹⁶ Auld F et al. Evidence for the efficacy of melatonin in the treatment of primary adult sleep disorders. *Sleep Med Rev*. 2017;34:10–22. PMID: 28648359

05 Doseringen en veiligheid (globaal kader)

Dit zijn geen voorschriften: het zijn gangbare gebruiksvensters uit literatuur en praktijkrichtlijnen. Bij medicatie, zwangerschap, borstvoeding of diagnose: altijd je arts raadplegen.

Magnesium (glycinaat/bisglycinaat)

- ▣ Veel gebruik: 200–400 mg elementair magnesium, 30–60 min voor slapen (populatiestudies koppelen hogere magnesiuminname aan betere slaapduur en -kwaliteit)¹⁷
- ▣ Start bij de onderkant als je een gevoelige maag hebt

Interacties / let-op

Magnesium kan de opname van sommige antibiotica (zoals quinolonen en tetracyclines) verminderen — houd minimaal **2 uur** tussen magnesium en die medicatie. Bij schildklierpillen en bisfosfonaten geldt vaak hetzelfde scheidingsprincipe.

Ashwagandha (KSM-66 voorbeeld)

- ▣ Veel gebruik: 300 mg, 2× daags bij maaltijd — evalueren na 4–6 weken (zie onderbouwing en veiligheid in RCT-literatuur¹⁴¹⁵)

Interacties / let-op

Niet combineren zonder arts bij schildklierziekte of bij gebruik van sedativa. Stop bij ongesteldelijke bijwerkingen en overleg.

Melatonine

- ▣ Veel microdosering: 0,3–0,5 mg, 30–60 min voor slapen
- ▣ Gebruik korte periodes en evalueer — niet blindeloos maandenlang op hogere doses

Interacties / let-op

Let op bij bloedverdunners en immunosuppressiva — melatonine wordt niet altijd verdragen door iedereen; overleg bij twijfel.

L-theanine

- ▣ Avond: vaak 100–200 mg voor slapen
- ▣ Kan overdag kleiner worden ingezet bij spansignalen (individueel)

Interacties / let-op

Overweg voorzichtig bij gebruik van bloeddrukmedicatie of stimulantia — bespreek bij combinaties met cafeïne als je gevoelig bent voor bloeddruk.

Bronnen

- ¹⁷ Zhang Y et al. Association of magnesium intake with sleep duration and sleep quality. PLoS One. 2022;17(1):e0261989. PMC8782427

06 Week-voor-week actieplan

Week 1: Quick wins

- Koele, donkere slaapkamer
- Schermen weg voor bed
- Vaste opstaantijd
- Cafeïne niet na lunch

Week 2–4: Ritme verdiepen

- Avondwandeling na diner
- Magnesiumglycinaat routinematig (zie hoofdstuk 5)
- Alcohol beperken en niet als slaapmiddel
- Alcohol niet vlak voor slapen — minimale 'relax' is een vals signaal voor je brein

Week 5–8: Verdieping

Nu gaat het niet om 'nog meer regels', maar om stabiliteit en meetbare verbetering. Kies één extra scherp punt — bijvoorbeeld consistent daglicht binnen een vast venster, of een vaste 'shutdown' van werk om 20:00.

- Mini-**slaapdagboek** 4× per week (gestandaardiseerde registratie verhoogt betrouwbaarheid)¹⁸
- Optioneel: voeg ashwagandha toe alleen als stress/nachtelijk wakker blijven nog leidend is
- Evalueer supplementkeuzes met startdatum — wat heeft geholpen, wat niet?

Meet je baseline — dan pas optimaliseren

Gebruik de gratis Leefstijlcheck om je uitgangspunt vast te leggen vóór je grote wijzigingen doorvoert en **herhaal na ±4 weken**. Zo voorkom je dat je blind stapelt zonder te weten wat werkte.

Bronnen

¹⁸ Carney CE et al. The consensus sleep diary: standardizing prospective self-monitoring. Sleep. 2012;35(2):287–302. PMC3250369

07 Veelgestelde vragen

Kan ik magnesium combineren met ashwagandha?

Ja, dat gebeurt veel — maar niet gelijktijdig innemen als je maag gevoelig is. Hanteer liever het 'één voorrang, na 2 weken uitbreiden' principe zodat je bijwerkingen kunt toeschrijven.

Hoe lang moet ik supplementen gebruiken?

Ashwagandha evalueer je meestal pas na enkele weken; magnesium kan eerder subtiele effecten geven. Stopperiodes en dosering zijn afhankelijk van je plan — bij twijfel: arts.

Mijn slaap is 'goed' maar ik word moe wakker — wat dan?

Kijk naar diepe slaap en stresscurve overdag, niet alleen naar 'uren gelegen'. Soms helpt eerder opstaan + sterker daglicht en minder alcohol meer dan een extra pil.

Helpt CBD-olie voor slaap?

Het bewijs is wisselend en productkwaliteit varieert sterk. CBD kan bij sommigen kalmeren en bij anderen juist alertheid geven. Het is geen eerste-lijn advies in deze gids; leg medicatie en leverenzymen altijd voor bij je arts.

Wanneer naar de huisarts met slaapproblemen?

Bij aanhoudende vermoeidheid overdag ondanks voldoende tijd in bed, luid snurken met apneu-vermoeden, onverklaarde pijn, depressieve klachten, of slaapproblemen die je dagfunctioneren ondermijnen: vraag professioneel onderzoek aan.

Wil je weten waar je staat?

Slaap is één van de zes domeinen die we meten in de gratis Leefstijlcheck. In een paar minuten zie je waar je op scoort — en welk profiel bij jou past.

perfectsupplement.nl/intake

Bronnen

- ¹ Wurtman RJ. Age-Related Decreases in Melatonin Secretion—Clinical Consequences. *J Clin Endocrinol Metab.* 2000;85(6):2135–2136. PMID: 10852443
- ² Hardeland R. Melatonin in Aging and Disease—Multiple Consequences of Reduced Secretion, Options and Limits of Treatment. *Aging Dis.* 2012;3(2):194–225. PMC3377831
- ³ Claustrat B, Leston J. Melatonin: Physiological effects in humans. *Neurochirurgie.* 2015;61(2–3):77–84.
- ⁴ Ohayon MM et al. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals. *Sleep.* 2004;27(7):1255–1273. PMID: 15586779
- ⁵ Leproult R, Van Cauter E. Effect of 1 week of sleep restriction on testosterone levels in young healthy men. *JAMA.* 2011;305(21):2173–2174. PMID: 21632481
- ⁶ Wittert G. The relationship between sleep disorders and testosterone in men. *Asian J Androl.* 2014;16(2):262–265. PMC3955336
- ⁷ Drake C et al. Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. *J Clin Sleep Med.* 2013;9(11):1195–1200. PMC3805807
- ⁸ Chang AM et al. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2015;112(4):1232–1237. PMID: 25535358
- ⁹ Okamoto-Mizuno K, Mizuno K. Effects of thermal environment on sleep and circadian rhythm. *J Physiol Anthropol.* 2012;31(1):14. PMC3427038
- ¹⁰ Blume C et al. Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. *Somnologie.* 2019;23(3):147–156. PMC6751071
- ¹¹ Schuster J et al. Magnesium Bisglycinate Supplementation in Healthy Adults Reporting Poor Sleep: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. *Nat Sci Sleep.* 2025;17. PMC12412596
- ¹² Rawji A et al. Examining the Effects of Supplemental Magnesium on Self-Reported Anxiety and Sleep Quality: A Systematic Review. *Cureus.* 2024;16(4):e59317. PMC11136869
- ¹³ Bannai M, Kawai N. New therapeutic strategy for amino acid medicine: glycine improves the quality of sleep. *J Pharmacol Sci.* 2012;118(2):145–148. PMID: 22293292
- ¹⁴ Lopresti AL et al. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Medicine.* 2019;98(37):e17186. PMC6979308
- ¹⁵ Chandrasekhar K et al. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. *Indian J Psychol Med.* 2012;34(3):255–262. PMID: 23439798
- ¹⁶ Auld F et al. Evidence for the efficacy of melatonin in the treatment of primary adult sleep disorders. *Sleep Med Rev.* 2017;34:10–22. PMID: 28648359
- ¹⁷ Zhang Y et al. Association of magnesium intake with sleep duration and sleep quality. *PLoS One.* 2022;17(1):e0261989. PMC8782427
- ¹⁸ Carney CE et al. The consensus sleep diary: standardizing prospective self-monitoring. *Sleep.* 2012;35(2):287–302. PMC3250369

Disclaimer

Deze gids is informatief en geen medisch advies. Bij aanhoudende slaapproblemen raden we aan contact op te nemen met je huisarts. Supplementen vervangen geen diagnose of behandeling.

© 2026 PerfectSupplement.nl — Onafhankelijk. Onderbouwd. Voor mannen 40+.